

# 감염후기침, 시간이 약입니다

감기 후 3~8주간 지속되는 기침 — 왜 생기고 어떻게 관리하면 좋은지 알아봅시다

# 감기 후 기침, 약 없이도 절반 이상은 좋아집니다

감염후기침 (Post-infectious Cough)은 평균 3~8주 내 자연 소실됩니다

# 50%+

## WHY PATIENCE MATTERS

그러나 감염후기침은 아급성 기침(3~8주)의 가장 흔한 원인이며, 8주를 초과해 만성화될 경우 다른 원인 평가가 필요합니다. 자연 경과를 이해하고 잘못된 헛기침 습관만 피해도 회복이 빨라집니다.

감염후기침 환자의 절반 이상은 약물 치료 없이도 시간이 지나면서 자연 호전됩니다 — 손상된 기도 점막과 신경이 회복되는 과정이 필요할 뿐입니다.

# 감염후기침 (Post-infectious Cough) 이란

감기·독감·코로나19 후에도 기침만 3주 이상 지속되는 상태

급성 상기도 감염 후 콧물·발열 등은 사라졌지만 기침만  
3주 이상 지속되는 상태로, 흉부 X-ray가 정상이고  
다른 원인이 배제된 경우 진단합니다.

바이러스가 기도 점막을 손상시키고 신경 수용체(TRPV1, TRPA1)를 과민하게 만들면, 작은 자극에도 기침 반사가 쉽게 유발됩니다. 이를 기침 과민 증후군(Cough Hypersensitivity Syndrome, CHS)이라 부르며, 감염후기침은 그 대표 사례입니다.

## DURATION

**3 – 8주**

평균 지속 기간 — 아급성 기침의 가장 흔한 원인입니다.

## PERSISTENCE AFTER URI

**약 25%**

감기 후 2주 이상 기침이 남아있는 환자 비율.

# 아급성 기침의 4가지 흔한 원인

감기 후 3주 이상 기침이 남는다면 — 대부분 이 네 가지에서 출발합니다

## CAUSE · 01

### 감염 후 기관지 과민성 (Post-viral BHR)

바이러스 감염으로 기도 점막이 손상되고 신경 수용체가 과민해진 상태. 찬 공기·먼지·웃음 등 작은 자극에도 기침이 유발됩니다. 보통 6~10주 내에 정상화됩니다.

## CAUSE · 02

### 상기도 기침 증후군 (UACS)

코·부비동에서 분비물이 목 뒤로 흘러내리며 (후비루) 기침을 유발하는 가장 흔한 만성 기침 원인. 코막힘·재채기·"목에 뭔가 걸린 느낌"·잦은 헛기침이 함께 나타납니다.

## CAUSE · 03

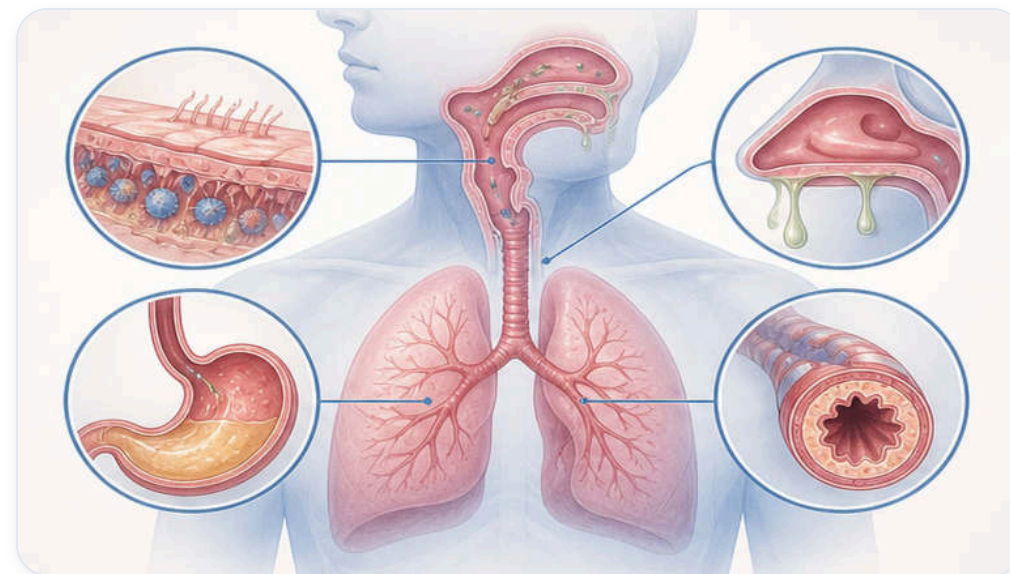
### 기침 변이형 천식 (Cough-Variant Asthma)

천명음·호흡곤란 없이 만성 기침만 나타나는 천식. 야간·새벽 기침, 운동·찬 공기 노출 후 악화가 특징. 폐기능 검사·기관지유발검사로 확인합니다.

## CAUSE · 04

### 위식도역류병 (GERD)

위산이 식도·후두를 자극해 기침을 유발. 식후·눕고 난 뒤 악화, 속쓰림·신물·목 이물감 동반. 위산억제제(PPI) 시도로 진단·치료를 동시에 합니다.



# 기침이 기침을 부른다 — Cough Begets Cough

조기에 기침을 억제하면 신경 감작의 악순환을 차단할 수 있습니다

## STEP · 01

### 바이러스 감염

감기·독감·코로나 등 바이러스가 기도 상피세포에 침투해 점막을 손상시킵니다. 이때부터 기침 신경이 자극에 노출됩니다.

## STEP · 02

### 기도 점막 손상 + 신경 감작

손상된 점막에서 염증 매개체가 분비되고, 기침 반사를 담당하는 미주신경 분지(TRPV1, TRPA1)가 과민화됩니다.

## STEP · 03

### 기침 역치 감소

평소엔 무시될 작은 자극(찬 공기, 먼지, 향수, 웃음)에도 기침이 유발됩니다. 환자는 "사소한 것에도 기침이 나온다"고 느낍니다.

## STEP · 04

### 반복적 기침 → 추가 점막 손상

고압의 기침이 반복되면 성대·기관 점막에 미세외상이 누적되며, 염증과 점액 분비가 다시 증가해 자극원이 됩니다.

## STEP · 05

### 기침 지속 · 만성화

자극→기침→손상→자극의 고리가 닫히면서 기침이 만성화됩니다. 8주를 넘기면 만성 기침으로 분류됩니다.

## KEY · 06

### 고리를 끊는 핵심 원리

의식적 기침 억제 (BCST), 충분한 수분 섭취, 자극원 회피로 신경 감작 단계에서 차단하면 만성화를 예방할 수 있습니다.

# 기침 충동이 올 때 이렇게 해보세요

행동적 기침 억제 치료 (BCST) — 기침 빈도를 최대 65% 감소시킵니다

## METHOD · 01

### 물 한 모금 천천히 삼키기

기침 충동이 오는 순간 물 한 모금을 천천히 삼킵니다. 가장 쉽고 효과적인 방법으로, 후두를 적시고 삼킴 반사가 기침 반사를 억제합니다.

## METHOD · 02

### 무설탕 사탕 빨기

사탕을 입에 물고 있으면 침 분비가 늘어 목을 촉촉하게 유지합니다. 외출·회의 등 물을 마시기 어려운 상황에서 유용합니다.

## METHOD · 03

### 코로 천천히 깊게 호흡

입을 다물고 코로 4초 들이쉬고 6초 내쉬기를 반복합니다. 입으로 차고 건조한 공기가 직접 들어오는 것을 막아 기도 자극을 줄입니다.

## METHOD · 04

### 입술 오므려 내쉬기 (Pursed-lip)

입술을 오므려 천천히 내쉽니다. 기도 압력을 일정하게 유지해 기관지 허탈을 막고, 기침 충동을 완화합니다.

## METHOD · 05

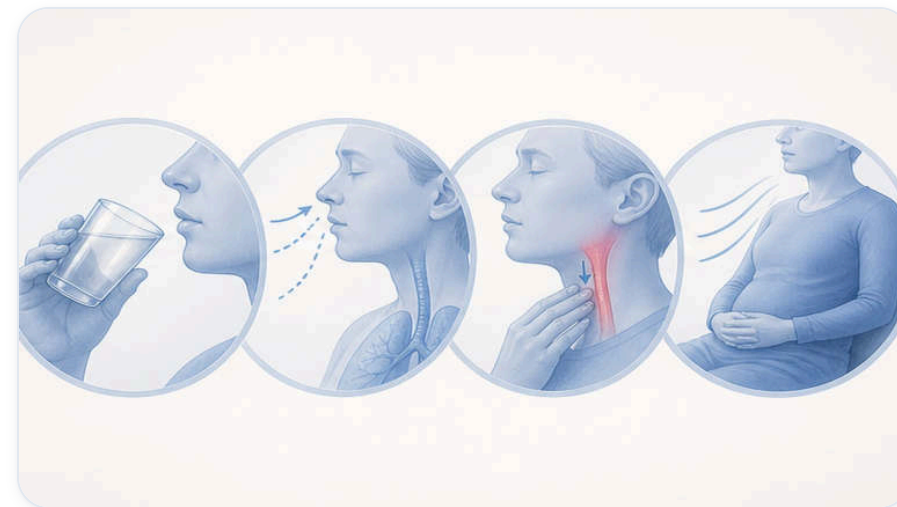
### 강한 삼키기 (Hard Swallow)

기침 충동이 올 때 의식적으로 힘을 주어 침을 삼킵니다. 삼킴 반사가 기침 반사를 직접 억제하는 효과가 임상 연구로 확인되었습니다.

## EVIDENCE · 06

### 근거 수준 — 환자 87% 호전

Vertigan 2006 RCT: 행동적 기침 억제 치료를 4회 시행 후 기침 빈도 최대 65% ↓, 환자의 87%가 호전을 보고했습니다.



# 생활 속 기침 관리

헛기침은 모기 물린 곳을 긁는 것과 같습니다 — 일시적 시원함 대신 악순환을 부릅니다

## + 이렇게 하세요 (DO)

- + 충분한 수분 섭취 — 하루 1.5~2L
- + 실내 습도 40~60% 유지 (가습기 활용)
- + 기침 총동 시 물 삼키기·사탕 빨기
- + 코로 천천히 깊게 호흡하기
- + 헛기침 대신 부드럽게 침 삼키기
- + 충분한 수면과 가벼운 규칙 운동

## - 이걸 피하세요 (DON'T)

- 습관적 헛기침 — "에헴!" 절대 금지
- 흡연·간접흡연·연기 노출
- 건조한 환경에 오래 머무르기
- 찬 공기에 갑자기 노출되기
- 큰 소리로 말하기·고함치기
- 카페인·알코올 과다 섭취



# 시간이 약입니다 — 회복 타임라인

감염후기침은 단계적으로 약해집니다 — 8주를 넘기면 추가 평가가 필요합니다



**참고** 코로나19 후 기침은 4~12주 시점 18~25%, 12주 이후 2.5~10%에서 지속되며, 약 43.7%에서 기도 과민성 양성이 확인됩니다.



# 치료 옵션 — 비약물이 1차, 약물은 의사 처방

증상이 심하거나 4주 이상 지속될 때 단계적으로 약물을 추가합니다

## NON-DRUG · 01

### 행동적 기침 억제 (BCST) + 꿀

물 삼키기·호흡법·사탕 빨기가 1차 권장 — 가장 효과적이며 부작용이 없습니다. 꿀(Honey)은 기침 빈도와 중증도를 개선합니다 — 단, 12개월 미만 영아 금기.

## NON-DRUG · 02

### 수분 섭취 + 자극물 회피

충분한 수분 섭취는 점액을 묽게 하고 점액섬모 청소를 촉진합니다. 연기·먼지·찬 공기 회피는 기도 자극을 줄여 기침 역치를 회복시킵니다.

## DRUG · 03

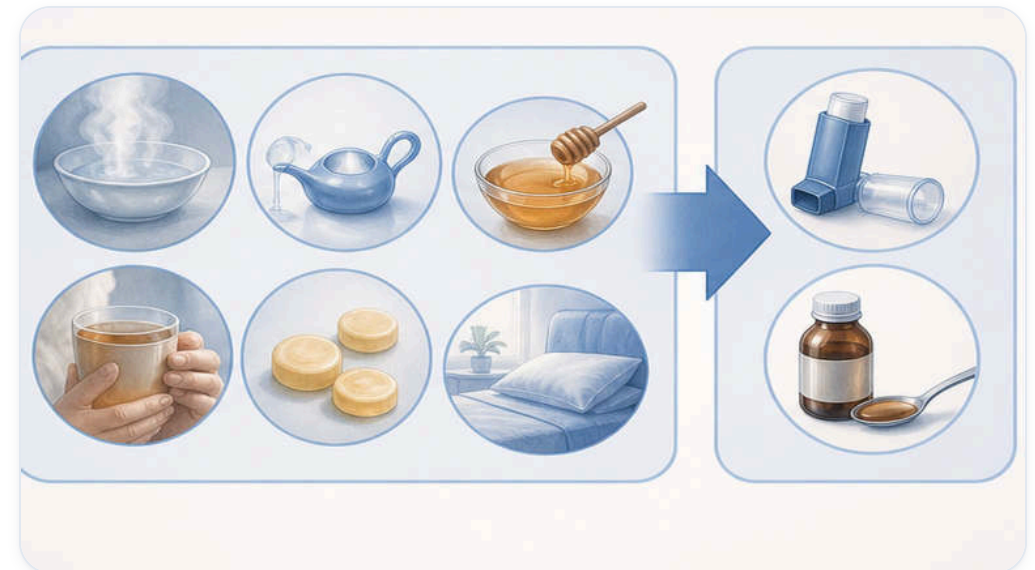
### 흡입 스테로이드 (ICS) ± 이프라트로피움

기도 염증·과민성이 의심되면 ICS를 2~4주 시도 (ERS/KAAACI 조건부 권고). 이프라트로피움은 기도 분비를 억제 — 치료 필요 수(NNT)=3.

## DRUG · 04

### 진해제 + 신경조절제 (불응성)

레보드로프로피진은 비마약성 진해제로 CNS 억제가 없습니다. 8주 이상 지속되는 불응성 기침에는 가바펜틴 등 신경조절제를 고려 (RCT 확인).



# 이런 증상이 있으면 즉시 병원으로!

아래 위험 신호 중 하나라도 동반되면 추가 검사가 필요합니다 — 한국은 결핵 중등도 부담 국가입니다



## 객혈 (Hemoptysis) — 피가 섞인 가래

폐암·결핵·기관지확장증의 위험 신호. 흉부 CT·기관지경 검사로 즉시 평가가 필요합니다.



## 설명되지 않는 체중 감소 + 야간 발한

악성종양·결핵·림프종의 전형적 동반 증상 — 흉부 CT, AFB 검사, 조직검사를 고려합니다.



## 급성기 이후 지속되는 발열 또는 호흡곤란

폐렴·결핵·심부전·폐색전증 가능성. 안정 시 호흡곤란, 쉼 목소리 지속도 함께 평가 — 폐기능검사·D-dimer 등.



## 기침 8주 이상 지속 — 만성 기침 진입

천식·역류·결핵 등 체계적 검사 알고리즘 적용. 기침 2주 이상 지속 시에도 결핵 검사를 고려합니다.

# 오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

감염후기침은 대부분 좋아지지만, 잘못된 습관이 회복을 방해합니다

01 감염후기침은 **3~8주 내** 대부분 자연 소실됩니다

02 약물 없이도 **50% 이상** 호전 — 시간이 약입니다

03 기침이 기침을 부르는 **악순환**을 의식적으로 끊으세요

04 헛기침 ("에헴!") — 모기 물린 곳 긁기, **금지**

05 기침 충동 시: **물 삼키기·코 호흡·사탕**

06 습도 40~60%·하루 1.5~2L 수분, **흡연·찬 공기** 회피

07 증상 심하면 ICS·진해제 — **의사 처방**으로만

08 객혈·체중감소·발열·8주 초과 → **즉시 병원**

# 감기 후 기침, 대부분 좋아칩니다

기침 충동이 올 때 물 삼키기·코 호흡으로 악순환을 끊고 자연 회복을 기다려 주세요

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요